

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE ESTRÉS PERCIBIDO — FORMA COMPLETA (PSS-14)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación Global de Estrés Percibido y Recursos de Afrontamiento

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Estrés Percibido de 14 Ítems (PSS-14).
Nombre Original (Inglés)	<i>Perceived Stress Scale - 14 Item Full Form (PSS-14)</i>
Autores Originales	Sheldon Cohen, Tom Kamarck y Robin Mermelstein (1983), Carnegie Mellon University.
Adaptaciones Españolas	González y Landero (2007, validación psicométrica estructural); Remor y Carrobles (2001, España).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Evaluación de estrés subjetivo y sensación de control.
Tipo de Instrumento	Autoinforme de 14 reactivos politómicos de 5 anclajes (0 = Nunca a 4 = Muy a menudo).
Población y Rango	Jóvenes y adultos (>= 15 años). Ámbitos clínicos, comunitarios, universitarios y de salud ocupacional.
Tiempo de Administración	5 a 8 minutos.
Régimen de Licencia	Dominio público para uso académico, de investigación y evaluación clínica no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

La PSS-14 representa la formulación original y más exhaustiva de la escala diseñada por Cohen y colaboradores (1983). Su objetivo es cuantificar el grado en el que situaciones cotidianas o extraordinarias de la vida son evaluadas por el sujeto como estresantes, impredecibles, incontrolables o sobrecargantes durante el último mes.

A diferencia de la versión abreviada de 10 ítems (PSS-10) optimizada para cribados masivos rápidos, la versión de 14 reactivos proporciona una evaluación más detallada de las respuestas adaptativas intermedias, incorporando facetas reflexivas adicionales relativas a la gestión de tareas imprevistas y la autoeficacia cotidiana. Sus propiedades psicométricas han sido ampliamente documentadas en estudios de salud comportamental, psiconeuroinmunología y trastornos psicofisiológicos.

3. ESTRUCTURA FACTORIAL DE 2 FACTORES (GONZÁLEZ & LANDERO, 2007)

Factor Clínico	Ítems	Rango Dir.	Contenido y Significación Psicológica
1. Percepción de Sobrecarga (Distrés)	1, 2, 3, 8, 11, 12, 14	0 a 28	Reactivos directos que expresan agobio, tensión nerviosa, enfado por falta de control y sensación de desbordamiento.
2. Autoeficacia / Control (Invertidos)	4, 5, 6, 7, 9, 10, 13	0 a 28	Reactivos positivos que valoran confianza en resolver dificultades, control del tiempo y sensación de dominio vital.
PUNTUACIÓN TOTAL PSS-14	1 al 14	0 a 56	Índice multidimensional integral de estrés percibido durante el último mes.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO

Consistencia Interna	Alfa de Cronbach de 0.83 a 0.87 en muestras hispanohablantes (González y Landero, 2007 reportaron alfa de 0.83 para la escala total y 0.78 para ambos factores).
Fiabilidad Test-Retest	Coefficiente de correlación intraclase $r = 0.75$ a 0.82 en intervalos de 2 semanas en población general y universitaria.
Validez Concurrente	Correlación positiva y robusta con inventarios de síntomas somáticos ($r = 0.58$), ansiedad estado-rasgo (STAI $r = 0.67$) y depresión (BDI $r = 0.63$).
Validez Convergente/Divergente	Correlación inversa estadísticamente significativa con optimismo vital (LOT-R $r = -0.49$), autoeficacia general ($r = -0.56$) y bienestar subjetivo.
Estructura Factorial Confirmatoria	Ajuste adecuado del modelo bifactorial correlacionado (RMSEA = 0.052, CFI = 0.94, TLI = 0.93) en estudios de análisis factorial confirmatorio en español.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ÍTEMS

Cada uno de los 14 ítems se responde en una escala de 5 opciones referida al **último mes**:

- **0** = Nunca | **1** = Casi nunca | **2** = De vez en cuando | **3** = A menudo | **4** = Muy a menudo.
- **Inversión de los 7 Reactivos Positivos:** Los ítems **4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13** están formulados de manera positiva y deben invertirse obligatoriamente antes de sumarse:

0 -> 4 | 1 -> 3 | 2 -> 2 | 3 -> 1 | 4 -> 0

- **Cálculo del Total PSS-14:** Suma de los 7 reactivos directos más los 7 reactivos invertidos. Rango de puntuación: **0 a 56 puntos**.

6. BAREMOS Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA (GONZÁLEZ & LANDERO, 2007)

Nivel	Puntuación	Estado Clínico y Significación	Conducta Asistencial Recomendada
Bajo	0 a 18	Estrés percibido bajo / basal normal	Demandas cotidianas equilibradas respecto a los recursos de afrontamiento. Mantener hábitos de autocuidado.
Moderado	19 a 37	Estrés moderado / Sobrecarga habitual	Tensión psicosocial habitual en presencia de estresores sostenidos. Recomendable entrenamiento en manejo del tiempo.
Alto	38 a 56	Estrés severo / Clínica-mente crítico	Sensación de desbordamiento grave y pérdida de recursos adaptativos. Alto riesgo psicosomático y emocional. Intervención clínica prioritaria.

COMPARABILIDAD CON PSS-10: Aunque la PSS-10 ha ganado mayor difusión en atención primaria por su brevedad, la PSS-14 ofrece mayor estabilidad psicométrica en investigaciones de psicología de la salud y en intervenciones que exploran la interacción entre la autoeficacia de afrontamiento y la sobrecarga cotidiana.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

PERFILES DE ESTRÉS Y GUÍA TERAPÉUTICA:

- **Perfil de Sobrecarga Reactiva:** Puntuación alta en el Factor 1 (ítems 1, 2, 3, 8, 11, 12, 14) con retención moderada del Factor 2; indica crisis por acúmulo de demandas externas recientes (laborales, familiares). Abordaje focalizado en reorganización ambiental y desactivación fisiológica.
- **Perfil de Indefensión / Colapso Adaptativo:** Puntuación alta en Factor 1 y elevación máxima en Factor 2 invertido (ítems 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13); el paciente percibe nulidad de capacidades de gestión. Indicación prioritaria de terapia cognitivo-conductual centrada en autoeficacia percibida.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN CRISIS VITAL

Paciente: Varón de 34 años, director financiero en proceso de reestructuración corporativa, que consulta por crisis de angustia vespertinas, tensión muscular generalizada, taquicardias sinusal episódica y rumiación nocturna continua.

Puntuación PSS-14 Total: 43 puntos (Rango Alto — Nivel Clínicamente Crítico).

- **Desglose factorial:** Factor Sobrecarga = 23/28 (sentimiento de falta de control total sobre imprevistos y problemas acumulados); Factor Autoeficacia Invertido = 20/28 (pérdida pronunciada de la percepción de capacidad para afrontar responsabilidades).

Conducta Asistencial: Se diagnostica Trastorno Adaptativo con Ansiedad. Se implementa un protocolo de intervención en 10 sesiones combinando técnicas de entrenamiento autógeno, delegación eficaz y reestructuración cognitiva sobre el catastrofismo laboral. En la reevaluación al término de la intervención, la puntuación en la PSS-14 descendió a 21 puntos (rango moderado bajo), con desaparición completa de los episodios de angustia.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA

ALERTA: INSTRUMENTO NO NOSOLÓGICO

La PSS-14 no establece diagnósticos psiquiátricos por sí misma. Puntuaciones ≥ 38 requieren cribado de depresión mayor, ansiedad generalizada, trastorno por estrés postraumático y trastornos somatomorfos.

CRITERIO TEMPORAL RETROSPECTIVO

El marco de referencia es el "último mes". No refleja estrés agudo de minutos u horas ni rasgos crónicos vitalicios estables de personalidad neurótica sin estresores concomitantes.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. *Journal of Health and Social Behavior*, 24(4), 385–396.
2. González, M. T., & Landero, R. (2007). Factor structure of the Perceived Stress Scale (PSS) in a sample from Mexico. *The Spanish Journal of Psychology*, 10(1), 199–206.
3. Remor, E., & Carrobes, J. A. (2001). Versión española de la Escala de Estrés Percibido (PSS-14): Estudio psicométrico en una muestra de personas con infección por VIH. *Ansiedad y Estrés*, 7(2-3), 195–201.
4. Cohen, S., & Williamson, G. M. (1988). Perceived stress in a probability sample of the United States. In S. Spacapan & S. Oskamp (Eds.), *The social psychology of health* (pp. 31–67). Sage Publications.